

TEMA 3.4 • UROLOGÍA

Retención Urinaria Aguda

PERFIL EUNACOM 4.01.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción

La **Retención Urinaria Aguda (RUA)** es una urgencia urológica común caracterizada por la incapacidad repentina y dolorosa de realizar la micción, a pesar de tener la vejiga llena. Es una condición que requiere una intervención inmediata para aliviar el dolor del paciente y prevenir complicaciones a largo plazo, como el daño renal permanente o la ruptura vesical.

Habitualmente, esta condición se presenta en pacientes con antecedentes de una **uropatía obstructiva baja**.

Etiología

La causa más frecuente de RUA es la obstrucción mecánica al flujo de salida de la orina. Entre las causas principales destacan:

- **Hiperplasia Prostática Benigna (HPB):** Es la causa más común en hombres mayores. El crecimiento glandular comprime la uretra prostática.
- **Cáncer de Próstata:** Puede presentarse como una RUA en etapas avanzadas.
- **Estenosis Uretral:** Antecedentes de trauma, infecciones (ITS) o instrumentación previa.
- **Causas Neurológicas:** Vejiga neurogénica, lesiones medulares o esclerosis múltiple.
- **Fármacos:** Uso de anticolinérgicos, antihistamínicos o descongestionantes que afectan la contractilidad del detrusor o aumentan el tono del esfínter.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de la RUA implica un desequilibrio entre la presión necesaria para expulsar la orina (generada por el músculo detrusor) y la resistencia uretral. Cuando la resistencia supera la capacidad contráctil del detrusor de forma aguda, se produce la retención.

Cuadro Clínico

El diagnóstico de la retención urinaria aguda es **fundamentalmente clínico**. El cuadro es inconfundible y se caracteriza por:

- **Dolor Hipogástrico:** Suele ser de inicio súbito y de gran intensidad. El paciente suele estar angustiado y con una necesidad imperiosa de orinar.
- **Imposibilidad de micción:** El paciente refiere que, a pesar del esfuerzo y el deseo, no logra evacuar orina.
- **Globo Vesical:** Al examen físico, se palpa una masa en el hipogastrio, de consistencia elástica, dolorosa y **mate a la percusión**. Esta masa corresponde a la vejiga distendida.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En pacientes ancianos o con neuropatía (como en la **Diabetes mellitus tipo 2**), el dolor puede ser menos intenso o estar ausente, presentándose más bien como una masa abdominal palpable o confusión (delirium). Siempre palpar el hipogastrio en adultos mayores con agitación.

Diagnóstico

Como se mencionó, el diagnóstico es **clínico**. No se debe retrasar el tratamiento (descompresión) para realizar exámenes de imagen si el globo vesical es evidente.

- **Examen Físico:** Palpación y percusión del hipogastrio. El tacto rectal es mandatorio (una vez aliviado el dolor) para evaluar el tamaño y consistencia de la próstata.
- **Ecografía Vesical:** Útil en casos de duda diagnóstica (por ejemplo, en pacientes obesos donde el globo vesical no es fácil de palpar) para

confirmar el volumen de orina retenido.

- **Laboratorio:** Se debe solicitar creatinina y electrolitos plasmáticos para evaluar la función renal, descartando una **Insuficiencia Renal Aguda** post-renal.

Manejo Inicial

El objetivo primordial es la **descompresión vesical inmediata**.

1. Instalación de Sonda Foley

Es el tratamiento de primera línea. Se debe utilizar una técnica aséptica y asegurar una lubricación adecuada de la uretra.

- **Conducta:** Se indica **Sonda Foley a permanencia**.
- **Seguimiento:** El paciente debe ser derivado a control con **Urólogo** para determinar la causa de base y planificar el tratamiento definitivo (por ejemplo, cirugía de próstata).

2. Tratamiento Farmacológico y Retiro de Sonda

Aunque la regla general es mantener la sonda hasta la resolución de la causa, las guías internacionales sugieren una alternativa: - Intentar el retiro de la sonda en **2 semanas**. - Asociar el uso de **Tamsulosina** (bloqueador alfa-1) antes del intento de retiro para relajar el cuello vesical y mejorar las probabilidades de éxito.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El riesgo de recidiva de la retención tras retirar la sonda es altísimo si no se ha corregido la causa obstructiva. Si el paciente vuelve a retener, se debe reinstalar la sonda y mantenerla hasta la cirugía.

Complicaciones de la Descompresión

- Al evacuar la vejiga, se deben tener en cuenta dos fenómenos posibles:
- **Hematuria ex vacuo:** Sangrado vesical leve debido a la descompresión brusca de los capilares de la mucosa. Generalmente es autolimitado.
- **Poliuria post-obstructiva:** Una diuresis excesiva tras liberar la obstrucción. Requiere vigilancia de electrolitos y estado de hidratación.

Cistostomía Suprapúbica

La cistostomía (punción suprapúbica para drenar la vejiga) es un procedimiento de excepción.

Indicaciones de Cistostomía:

1. **Fracaso del sondaje uretral:** Si la Sonda Foley no pasa tras **2 o máximo 3 intentos**. - *Protocolo:* Habitualmente la enfermera realiza el primer intento; si falla, debe intentar el médico o urólogo. Si tras 3 intentos no hay éxito, se procede a la cistostomía. 2.

Contraindicación de Sonda Foley: Principalmente ante la sospecha de **sección uretral** o trauma uretral.

TABLA 3.4.1: SITUACIÓN VS CONDUCTA CORRECTA

SITUACIÓN	CONDUCTA CORRECTA
RUA por HPB estándar	Sonda Foley
Fractura de pelvis con sangre en el meato	Contraindicada Sonda Foley → Cistostomía
Imposibilidad de pasar la sonda tras 3 intentos	Cistostomía Suprapúbica
Sospecha de rotura uretral	Cistostomía Suprapúbica

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Sospecha de Sección Uretral: Ante un paciente con trauma (ej. fractura de pelvis o caída en horquillada) que presenta sangre en el meato urinario, equimosis perineal o próstata "flotante" al tacto rectal, **está absolutamente contraindicado intentar poner una sonda Foley**, ya que se puede transformar una rotura parcial en una completa. En este caso, la vía de elección es la cistostomía.

Resumen para el EUNACOM

- El diagnóstico de RUA es **clínico** (dolor + globo vesical).
- El manejo inicial es la **Sonda Foley**.
- Se deriva al especialista para estudio de la causa (habitualmente **Hiperplasia Prostática Benigna**).
- La **Cistostomía** se reserva para cuando el sondaje falla o hay contraindicación por trauma uretral.
- El uso de **Tamsulosina** puede ayudar en el intento de retiro de sonda a las 2 semanas, pero el manejo definitivo suele ser quirúrgico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de setenta y cinco años, hombre, con antecedente de hiperplasia prostática benigna en tratamiento médico. Consulta a urgencias por dolor hipogástrico intenso de cuatro horas de evolución y refiere no haber podido orinar en ningún momento desde entonces. Al examen físico se palpa una masa hipogástrica globosa, tensa y dolorosa. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Retención Urinaria Aguda. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La retención urinaria aguda se presenta con dolor hipogástrico intenso, imposibilidad absoluta de orinar y globo vesical palpable al examen físico; el diagnóstico es clínico
- El tratamiento inicial y más importante es la instalación de sonda Foley, que se mantiene a permanencia hasta la resolución quirúrgica de la causa de base
- La sonda Foley se instala primero por la enfermera; si falla en dos intentos se llama al urólogo; si el urólogo también falla, se indica cistostomía suprapúbica
- Ante sospecha de sección uretral, como en fractura de pelvis, la instalación de sonda Foley está absolutamente contraindicada y se va directamente a cistostomía suprapúbica
- Las guías permiten intentar retirar la sonda Foley a las dos semanas con tamsulosina si hay bajo riesgo de recidiva, pero la regla general es mantenerla hasta la cirugía definitiva
- La causa más frecuente de retención urinaria aguda es la hiperplasia prostática benigna, seguida del cáncer de próstata
- El globo vesical es la vejiga muy distendida por orina retenida y es el hallazgo físico cardinal en la retención urinaria aguda

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RETENCIÓN URINARIA AGUDA)**PREGUNTA 1**

Paciente de setenta y cinco años, hombre, con antecedente de hiperplasia prostática benigna en tratamiento médico. Consulta a urgencias por dolor hipogástrico intenso de cuatro horas de evolución y refiere no haber podido orinar en ningún momento desde entonces. Al examen físico se palpa una masa hipogástrica globosa, tensa y dolorosa. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Solicitar ecografía vesico-prostática urgente para confirmar el diagnóstico
- B) Instalar sonda Foley de inmediato para drenar la vejiga
- C) Realizar cistostomía suprapúbica como primera medida de manejo
- D) Administrar tamsulosina endovenosa para intentar desobstruir la uretra
- E) Derivar de urgencia a urología sin instalar sonda Foley

PREGUNTA 2

Paciente de sesenta años llega a urgencias en estado inconsciente tras un accidente de tránsito. Al examen se objetiva fractura de pelvis. Se decide instalar sonda Foley para monitoreo de diuresis. El médico de urgencias intenta instalarla dos veces sin éxito. ¿Cuál es la conducta correcta?

- A) Insistir con más intentos de instalación de sonda Foley hasta lograr pasarla
- B) Realizar cistostomía suprapúbica de inmediato
- C) Derivar a urología y esperar a que llegue antes de cualquier intervención
- D) Administrar furosemida para disminuir la producción de orina mientras se espera
- E) Instalar sonda Foley de menor calibre para facilitar el paso

PREGUNTA 3

Paciente de sesenta y ocho años con retención urinaria aguda por hiperplasia prostática benigna. Se instala sonda Foley con buena respuesta. El médico considera retirar la sonda a las dos semanas y agrega tamsulosina. ¿Cuál afirmación es correcta respecto a esta conducta?

- A) Es la conducta estándar porque la sonda Foley debe retirarse siempre a las dos semanas
- B) Es una conducta permitida por guías internacionales en pacientes seleccionados con bajo riesgo de recidiva, aunque la regla general es mantener la sonda hasta la cirugía
- C) Es incorrecta porque la tamsulosina no tiene indicación en la retención urinaria aguda
- D) Es incorrecta porque la sonda Foley debe retirarse siempre al séptimo día sin fármacos adicionales
- E) Es la conducta incorrecta porque la cirugía debe realizarse antes de retirar la sonda Foley

RESUMEN: RETENCIÓN URINARIA AGUDA

La retención urinaria aguda es una emergencia urológica caracterizada por la imposibilidad súbita de orinar en un paciente que habitualmente tiene antecedente de uropatía obstructiva baja. Las causas más frecuentes son la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. El cuadro clínico es inconfundible: dolor hipogástrico intenso, imposibilidad absoluta de orinar, y al examen físico se palpa el globo vesical, que es la vejiga distendida y llena de orina. El diagnóstico es completamente clínico y no requiere confirmación con exámenes de imagen en el momento agudo. El manejo inicial y más importante es la instalación de una sonda Foley, que permite drenar inmediatamente la vejiga y aliviar el dolor. La conducta correcta no es la cistostomía suprapúbica, que se reserva para situaciones específicas. Una vez instalada la sonda Foley, se mantiene a permanencia hasta que se resuelva la causa de base con cirugía, la cual debe ser coordinada con urología. Las guías internacionales permiten intentar retirar la sonda Foley a las dos semanas agregando tamsulosina si hay factores que indican menor riesgo de recidiva, pero la regla general es mantenerla hasta la cirugía definitiva dado el alto riesgo de nueva retención en el corto plazo. Las indicaciones de cistostomía suprapúbica son precisas y hay que conocerlas. La principal es la imposibilidad de instalar la sonda Foley después de dos intentos por la enfermera y luego un intento por el urólogo. La otra indicación fundamental es la sospecha o diagnóstico de sección uretral, por ejemplo en el contexto de una fractura de pelvis, donde la instalación de sonda Foley está absolutamente contraindicada por el riesgo de completar la lesión uretral. Ante sospecha de sección uretral con cualquier trauma pélvico, no se intenta instalar sonda Foley y se va directamente a la cistostomía suprapúbica.